随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

胃溃疡　题目说穿孔默认急性穿孔　十二指肠溃疡

注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿孔好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁袜子-前面穿孔、后面出血

慢慢在后面穿

血管在一些结构的后面（被保护起来）

小凯笔记自行整理

GU：好发部位、穿孔部位、出血部位 → 胃小弯

DU：好发部位、穿孔部位（急性穿孔→十二指肠球部前壁；慢性穿孔→十二指肠球部后壁）、出血部位

3.胃溃疡的病理变化

（1）圆形或椭圆形、多＜2cm、边缘整齐如刀切、底部平坦、深达肌层、阶梯状（贲门侧深+幽门侧浅本身有钱），**周围黏膜皱襞呈放射状向 ttsx 溃疡集中**（溃疡底部瘢痕牵拉）

纤维

VS 胃癌溃疡 火山口或菜花状，多>2cm，边缘不整齐，底部凹凸不平，深度较浅

（2）溃疡底部由内向外 机体在慢慢修复，肉芽组织从底部开始长，越靠近外面越陈旧

HP对中性粒细胞趋化作用

新 ↓ 旧

①炎性渗出层：中性粒细胞等白细胞、纤维素（纤维蛋白）

②坏死组织层：伊红色坏死组织（**纤维素样坏死**）=胶原纤维的坏死（染色染出来与纤维素一样）

③**肉芽组织**层：大量新生毛细血管和成纤维细胞 →产生胶原纤维

④瘢痕组织层：**增殖性/闭塞性动脉内膜炎**（管腔狭窄闭塞、血栓形成）→影响再生使溃疡

坏处

动脉内膜受到炎症刺激发生增殖

不易愈合、但**防止溃疡血管破裂出血**

好处

临床上消化性溃疡的上消化道出血量一般没有很大

肝硬化的食管胃底静脉曲张破裂出血量大

肌层破坏不能完全再生



图 11-3　胃溃疡

胃小弯近幽门处溃疡，边缘整齐，周围黏膜水肿，黏膜皱襞向周围放射状排列。

胶原纤维收缩

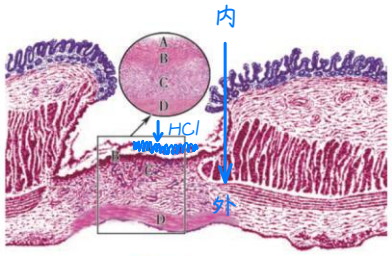
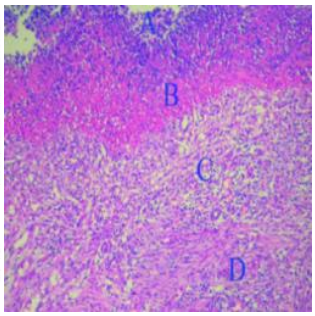


图 11-4　胃溃疡

溃疡断面呈斜置漏斗状，深达肌层，溃疡底部由内向外分为四层：A 为炎性渗出层；B 为坏死组织层；C 为肉芽组织层；D 为瘢痕层。



4.结局：渗出物及坏死组织逐渐被吸收、排出，已被破坏的肌层不能再生，由底部的**肉芽组织**增生形成瘢痕组织修复，同时周围**黏膜上皮再生**覆盖溃疡面而愈合

再生能力强

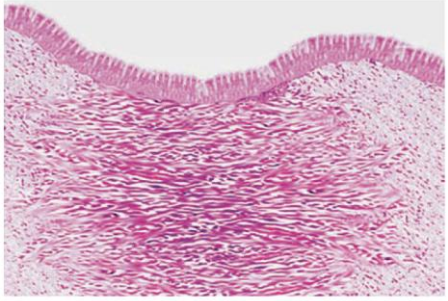


图 11-5　消化性溃疡愈合